FACULTE DE MEDECINE DE BEJAIA
UNITE D'ENSEIGNEMENT INTERGREE 1

PSYCHOLOGIE DE LA DOULEUR

Pr. EH. ADJA* - Dr S. ZEGGANE**
(*) CHU DE Bejaia
(**)Service de psychiatrie-Addictologie-CHU de Tizi Ouzou

Campus Aboudaou octobre 2024

INTRODUCTION

- Définir la douleur n’est pas une chose facile.
- Dans le langage courant, le mot douleur prend des significations diverses : "maladie" ,"trouble", "peine", "tristesse", "souffrance"..
- Pendant le sommeil, sous anesthésie générale, on ne souffre pas.
- La conscience est indispensable pour ressentir la douleur.
- C’est donc une évidence d’affirmer que la douleur est un phénomène **subjectif**.

- Ce qui caractérise la douleur, c’est qu’il s’agit d’une expérience
  - désagréable,
  - subjective,
  - individuelle.
- On ne peut mesurer la douleur directement comme on prend la température, la tension artérielle...
- On ne peut démontrer objectivement la douleur. C’est pourtant un phénomène très réel.
- Comme la "bonne humeur", le vague à l’âme ou la fatigue, la douleur est un phénomène subjectif.
- Pour les autres individus, il n’y a pas de preuve formelle.

- On ne peut seulement qu'écouter la description verbale que vous faites de votre douleur, qu'observer des changements dans votre attitude, dans votre comportement.
- Habituellement, le traitement d'une douleur se confond avec celui de sa cause.
- Lorsque c'est insuffisant, on doit faire appel à une approche thérapeutique différente.
- La douleur devient la maladie à traiter.

Trois éléments fondamentaux vont conditionner le succès des traitements :

1. **Comprendre la nature de la douleur** : De nombreux processus sont capables de créer, d'entretenir, d'amplifier une douleur. Une bonne compréhension de ces facteurs, de leur rôle, est essentielle.
2. **Accepter la réalité de la douleur** : Il ne suffit pas d'accepter superficiellement, mais d'aller en profondeur.

   Il faut admettre la douleur dans son ensemble, avec des réactions psychologiques qui l'accompagnent.

   Il faut accepter la signification de votre douleur, le rôle qu'elle joue dans votre vie.

3. **Adhérer aux traitements prescrits en faisant confiance et en coopérant avec l'équipe médicale soignante.**

- Il faut savoir que de nombreuses personnes assimilent la sensation de douleur à la cause de la douleur.
- Il y a une nuance qui n’est pas toujours évidente. La confusion est entretenue par le fait que, dans la majorité des douleurs récentes ou aiguës, le traitement de la douleur est celui de la cause.
- Pour la douleur chronique, le traitement ne sera pas obligatoirement ou exclusivement celui de la cause. **On doit envisager l’expérience douloureuse dans son ensemble.**

- Une autre difficulté provient du fait que les individus réagissent différemment à la douleur. On dit couramment de certaines personnes qu'elles **sont "résistantes à la douleur",** "dures au mal", ou, au contraire, "**douillette"**.
- En fait ces différences sont des variations habituelles en biologie.
- Qui s'étonne des variations de poids, de taille, des chiffres de tension artérielle...
- Ces variations de sensibilité à la douleur **entretiennent le doute que certaines personnes "exagèrent" leur douleur**.

PIEGES D'UNE MAUVAISE COMPREHENSION DE LA DOULEUR

- Les notions que nous avons développées nous permettent de souligner deux principaux pièges dus à une mauvaise compréhension de ce qu'est la douleur.

➢ **Le premier piège est que le caractère subjectif** individuel de la douleur fait que la famille, les amis, les médecins, peuvent vous **suspecter et vous accuser d'augmenter la gravité de votre douleur et même d'avoir une douleur imaginaire**. Pourtant votre douleur et votre condition sont bien réelles.

- **Le second piège est lié à la séparation habituellement établie dans notre société entre le corps et l'esprit,** entre le somatique et le psychologique.
- Une telle séparation ne peut se concevoir pour la douleur chronique.
- Cette conception inexacte est cependant fréquente et s'explique par les raisons suivantes.
- Dans la majorité des cas, les douleurs que nous éprouvons sont des douleurs de courte durée.
- Elles servent de signal d'alarme qui attire l'attention sur une lésion organique (douleurs d'appendicite, douleurs dentaires...).

- L’apparition de cette douleur fait consulter un médecin.
- Les caractères de cette douleur lui permettront de localiser l’organe malade, de pratiquer les examens nécessaires.
- Le traitement fait habituellement disparaître la douleur.
- Dans ce cas, la douleur n’a été qu’un élément d’orientation.
- La douleur apparaît comme la manifestation d’un désordre anatomique.
- La nature même de la douleur n’a pas été analysée.
- C’est uniquement le désordre anatomique qui a été traité.
- Cette conception de la douleur est familière à la fois pour les malades et pour les médecins.

Dimension psychologique de la douleur

- Réactions psychiques **à une douleur organique**
- Expression somatique **d'une souffrance psychique (**Coexistence d'une douleur organique et d'une psychopathologie indépendante de la douleur)

Réactions psychiques à l'organicité

- Réactions anxieuses et/ou dépressives dues :

➢ Aux sensations douloureuses persistantes

➢ A la confrontation à la maladie, à la peur de mourir…

➢ Aux répercussions de la maladie: handicap, mutilations, changement de statut…

Expression somatique d’une souffrance

- Douleur réactionnelle à début ponctuel, exprimant la souffrance liée à un traumatisme psychologique
- Douleur exprimant la psychopathologie sous jacente

Douleurs mixtes chez la personne âgée

- Douleurs dues aux maladies: arthrose…
- Angoisse dues à l’approche de la mort
- Pertes successives: perte fonctionnelles, deuils des proches, isolement, soucis pécuniaires, changement de domicile….

Douleurs mixtes post - accidentelles

- Douleurs dues aux blessures et cicatrices
- Angoisse dues au risque de mourir ou trauma psychique face à la mort
- Pertes successives: dégâts corporels et esthétiques, perte fonctionnelles, soucis pécuniaires, perte de l'emploi, parfois deuil de proches….

Pronostic d’une douleur psychogène

- Douleurs ayant un rôle psycho dynamique

Atténuation possible mais pas une sédation complète, nécessité de résoudre la problématique en psychothérapie

- Douleurs ” béquille nécessaire à vivre ”

Rôle protecteur de la douleur qui évite une décompensation psychique grave : elle doit être écrêtée mais respectée

REACTIONS PSYCHOLOGIQUES ET DOULEURS

- Une douleur qui dure depuis plusieurs mois, plusieurs années, s'accompagne de difficultés psychologiques.
- Ce fait est habituel, presque obligatoire.
- Cela ne veut pas dire pour autant que vous êtes malade mental.

LA DIMENSION PSYCHIQUE DE LA DOULEUR AIGUE

- La dimension psychique est souvent oubliée, voire totalement ignorée, cependant elle existe réellement.
- La lésion corporelle accapare toutes les attentions.
- La plainte douloureuse exprime aussi bien la douleur physique ressentie que la souffrance psychique, mais le patient et le soignant ne les différencient pas.

Constat sur la prise en charge de la souffrance psychique lors de la douleur aigue

- Devant la persistance de la plainte du patient, les soignants n'hésitent pas à augmenter les traitements antalgiques alors que la souffrance psychologique n'est pas prise en compte
- Si la souffrance psychologique est prise en compte, elle est le plus souvent soulagée par la prescription de médicaments.

ELEMENTS CONSTITUANT LA PART PSYCHIQUE DE LA DOULEUR AIGUE

- Choc psychique lors de la lésion (circonstances, état de choc...)
- Angoisse liée à la maladie, à l'intervention, aux dégâts corporels (devenir, changements de mode de vie, risque vital...)
- Angoisse due à des douleurs antérieures non calmées qui amène le patient à majorer sa plainte de peur de manquer d'antalgique et ce, tout à fait inconsciemment

- Psychopathologie sous-jacente pouvant entraîner des réactions exacerbées
- Facteurs environnementaux : tout événement concomitant, s’il présente un caractère de gravité, peut se répercuter au niveau de son vécu et donc de sa douleur

- Lors de douleur aiguë, au-delà de la composante sensorielle due à la lésion, la composante affective et émotionnelle doit être prise en compte de façon systématique, d'autant plus si la plainte parait anormalement élevée

Attention au risque de chronicisation

Prise en charge du douloureux chronique

- Tout soignant doit savoir élargir sa compréhension du malade à un ensemble de facteurs psychosociaux susceptibles d'amplifier ou d'entretenir la douleur
- Dans la plupart des cas, la collaboration avec le psychiatre ou le psychologue est souhaitable ; la difficulté est alors de faire accepter la démarche au malade, démarche qui ne doit pas être interprétée comme la preuve que l'on croit à une douleur imaginaire

Établir une relation de confiance

- Le premier contact avec le malade douloureux chronique peut être délicat pour le soignant du fait de l'agressivité du patient et des sentiments de frustration et de mise en échec qui se dégagent du discours du patient
- La relation est toujours facilitée lorsque le soignant montre clairement au patient **qu'il croit à sa douleur et fait preuve d'empathie**
- Croire à la douleur ne signifie pas accepter toutes les conceptions du malade sur son état ou sur la nature de la douleur : il faut savoir expliquer que les causes sont diverses, qu'il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit, l'être humain est un tout
- Savoir être disponible pour écouter et créer le climat de confiance indispensable à une relation de qualité : prendre du temps

Éléments pouvant constituer la part psychique de la douleur chronique

- le contexte socio-économique (assurance, travail) l'aide d'une assistante sociale peut s'avérer utile
- Le contexte familial (renforcement, rejet, attention...)
- le contexte affectivo-émotionnel (dépression, troubles de la personnalité)
- La composante cognitive (savoir, connaissance) elle précise la façon dont le patient se représente la cause de sa douleur et son attitude vis-à-vis de la douleur. Les arrière-pensées et les fausses idées doivent être clarifiées car elles alimentent souvent l'angoisse du patient alors la reformulation de la situation aidera le patient à adopter un comportement plus adapté vis-à-vis de sa douleur

- La composante comportementale: il faut répertorier les diverses manifestations motrices ou verbales témoignant de la douleur lors de l’entretien, lors de l’examen clinique, dans les situations statiques et dynamiques (mimiques, soupirs, attitudes antalgiques, limitations des mouvements, attitudes guindées…)

CONCLUSION

- Il y a toujours une relation entre la douleur chronique et les émotions
- Plusieurs facteurs peuvent avoir un rôle sur la douleur chronique et notamment :
  - l'entourage socio-familial et ses réactions ont un impact sur la douleur du patient
  - Le contexte socio-économique
- Éléments pouvant faciliter la prise en charge du douloureux chronique :
  - Relation de confiance entre le patient et les soignants
  - Prise en charge pluridisciplinaire, notamment psychologique
  - Information des professionnels de santé